

TEMA 2.10 • GINECOLOGÍA

Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU)

PERFIL EUNACOM 2.01.1.075

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU)

1. NIC — Neoplasia Intraepitelial Cervical

Causa: VPH (principalmente serotipos de alto grado: 16, 18, 31, 33, 45...).

Clínica: Asintomática — hallazgo en PAP → colposcopia + biopsia.

Colposcopia: Progresión lesional: Lesión acetowhite (blanca) → punteado rojo → mosaico/reticulado → vascularización atípica → úlcera (→ sospecha de cáncer).

Clasificación

TABLA 2.10.1: GRADO VS DISPLASIA

GRADO	DISPLASIA	CARACTERÍSTICA
NIC 1	Leve	Displasia 1/3 basal
NIC 2	Moderada	Displasia 2/3
NIC 3	Severa	Displasia > 2/3
Carcinoma in situ	Total	Sin invasión de lámina basal

Tratamiento

TABLA 2.10.2: GRADO VS TRATAMIENTO

GRADO	TRATAMIENTO
NIC 1	Seguimiento con PAP + colposcopia (preferido) O crioterapia con nitrógeno líquido O tipificación VPH
NIC 2, NIC 3, Ca in situ	Conización terapéutica (cono caliente con asa LEEP o láser)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Dos tipos de cono: - **Cono biopsico** (frío): en disociación colpo-citológica (PAP muy alterado + colposcopia normal) - **Cono terapéutico** (asa LEEP/caliente): en NIC 2, NIC 3 o carcinoma in situ con colposcopia alterada
El cono cervical conlleva riesgo de **incompetencia cervical** en embarazos futuros.

2. Cáncer de Cuello Uterino (CCU)

Causa: VPH alto grado (16, 18, 31, 33, 45...).

- **Clínica:**
- **Sinusorragia** (sangrado durante/después de relaciones sexuales) — signo de patología cervical
- Genitorragia
- Puede ser asintomático (detectado en screening)

Diagnóstico: Colposcopia → lesión ulcerada, irregular, hipervascularizada → **biopsia** (histológico).

Pronóstico: Determinado por la invasión de parametrios.

Tratamiento según Tamaño

TABLA 2.10.3: TAMAÑO VS ESTADIO FIGO

TAMAÑO	ESTADIO FIGO	TRATAMIENTO
< 4 cm	≤ IB1	Histerectomía radical (útero + cuello + 1/3 superior vagina + anexos + tejido parametrial)
> 4 cm o avanzado	> IB2	Quimiorradioterapia concurrente
Metástasis a distancia	IV	Tratamiento paliativo

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Post-histerectomía radical: seguimiento con PAP de cúpula vaginal.

3. Cáncer de Vagina

Similar al CCU en causa (VPH), diagnóstico (especuloscopia + biopsia) y tratamiento (cirugía ± quimiorradioterapia).

- **Clínica diferencial:**
- Sinusorragia + genitorragia (igual que CCU)
- **Prurito vaginal** (diferencial con candidiasis)
- **Adenopatías inguinales** (la vagina drena también a ganglios inguinales, a diferencia del cuello que drena solo a ganglios pélvicos)

Pronóstico: Determinado por invasión de parametrios (igual que CCU).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1. NIC — Neoplasia Intraepitelial Cervical
- Clasificación
- Tratamiento
- 2. Cáncer de Cuello Uterino (CCU)
- Tratamiento según Tamaño
- 3. Cáncer de Vagina
- VPH (principalmente serotipos de alto grado: 16, 18, 31, 33, 45...).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA MALIGNA DEL CUELLO UTERINO (NIC Y CCU))**PREGUNTA 1**

Respecto a Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A)** El diagnóstico de Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Patología Maligna del Cuello Uterino (NIC y CCU). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PATOLOGÍA MALIGNA DEL CUELLO UTERINO (NIC Y CCU)

Colposcopia: Progresión lesional: Lesión acetowhite (blanca) → punteado rojo → mosaico/reticulado → vascularización atípica → úlcera (→ sospecha de cáncer). Similar al CCU en causa (VPH), diagnóstico (especuloscopia + biopsia) y tratamiento (cirugía ± quimiorradioterapia).